

Nombre : MAURICIO MARTINEZ BASSO

Edad : 45 AÑOS

Fecha Examen: 18-04-2026

Fecha Informe: 18-04-2026

RADIOGRAFÍA RETROALVEOLAR PERIAPICAL TOTAL
RADIOGRAFÍA RETROALVEOLAR BITEWING

MAXILAR:

Reabsorción ósea marginal horizontal moderada, severa en distal de dientes 1.1 y 2.1; vertical severa en mesial de diente

1.1. Cálculo dentario marginal

Diente 1.8: No se observa

Diente 2.8: Ausente

Diente 1.1: Restaurado. Cámara pulpar retraída, conducto amplio. Espacio periodontal ensanchado, se sugiere evaluar estado pulpar

Diente 1.5: Lesión de caries de esmalte distal

Diente 1.6: Lesiones de caries de esmalte proximales

Diente 1.7: Investigar sintético radiopaco oclusal

Dientes 2.1 y 2.2: Cavidad o restauración radiolúcida cérvico-distal, se sugiere evaluar clínicamente

Diente 2.4: Lesión de caries de esmalte mesial

Diente 2.5: Lesión de caries de esmalte distal. Investigar sintético radiopaco oclusal

Diente 2.6: Lesión de caries de esmalte mesial. Caries dentinaria cérvico-distal. Nótese área radiolúcida de límites difusos en zona interradicular, se sugiere evaluar compromiso de furca clínicamente

Diente 2.7: Extrusión. Extensa destrucción corono-radicular penetrante. Conductos estrechos. Procesos osteolíticos periapicales de límites difusos

MANDIBULA:

Reabsorción ósea marginal horizontal moderada, severa en dientes 3.5, 3.6, 4.1 y 4.2; vertical severa en mesial de diente

3.4. Cálculo dentario marginal

Desdentado parcial

Diente 3.1: Caries dentinaria cérvico-distal. Espacio periodontal apical ensanchado

Diente 3.2: Cavidad o restauración radiolúcida cérvico-mesial, se sugiere evaluar clínicamente

Diente 3.4: Lesión de caries de esmalte distal

Diente 3.5: Lesión de caries de esmalte mesial. Investigar cavidad o restauración radiolúcida cérvico-distal

Diente 3.6: Restaurado. Calcificaciones distróficas en cámara pulpar, conducto estrecho en raíz mesial. Espacio periodontal francamente ensanchado en raíz mesial, se sugiere evaluar estado pulpar

Diente 4.1: Atrición coronaria. Cámara pulpar retraída, conducto amplio. Espacio periodontal apical ensanchado, se sugiere evaluar clínicamente

Diente 4.4: Cavidad o restauración radiolúcida ocluso-distal penetrante. Cámara y conducto amplios. Proceso osteolítico periapical de forma y límites parcialmente definidos, se sugiere evaluar clínicamente

Diente 4.8: Mesioversión. Investigar sintético radiopaco oclusal.

Nótese en reborde óseo alveolar residual en zona de dientes 4.6 y 4.7 se observa área de menor densidad ósea en hueso alveolar de límites difusos, con franco aumento de densidad hacia caudal, se sugiere evaluar clínicamente y estudio complementario Cone Beam CT para descartar patología ósea

Atentamente,

Dr. Felipe Gardías Baladrón
Radiólogo Oral y Máxilo-Facial

SEDE PROVIDENCIA
Gral. Holley 2381, Of 608
providencia@odontox.cl

SEDE MAIPÚ
Av. Los Pajaritos 3195, of 1402
maipu@odontox.cl

SEDE SAN BERNARDO
Av.Colón Sur 441
sanbernardo@odontox.cl